

参与治疗与疗效评定。

1.2 治疗方法

1.2.1 治疗组 为方便使用同时也为了准确掌握每次使用中药剂量,我科委托天津疗养院制剂室把活血通络中药打粉装袋,每袋重约50 g,活血通络中药主要由透骨草、五加皮、海桐皮、威灵仙、苏木等药物组成,每次使用一袋,先加80℃以上的热水500 mL浸泡10 min,倒入药浴治疗池中后加地下温泉水30 000 mL稀释。根据个体差异,首次浸浴温度宜在34~37℃,2~3 d,待机体适应后,将水温调整到38~42℃,开始浸浴每次20 min,根据身体情况无禁忌证者可适当延长浸泡时间,25~35 min/次,1次/d,10次为一疗程^{[3]426}。

1.2.2 对照组 口服芬必得胶囊(中美天津史克制药有

限公司)0.15 g,2次/d;盐酸氨基葡萄糖胶囊(香港澳美制药厂)0.75 g,2次/d^[4]。两组治疗时间均为20 d。

1.2.3 疗效标准 治愈:局部症状、体征消失,X线片骨关节增生停止;显效:局部症状、体征基本消失,X线片示骨关节已增生的骨质无变化;好转:症状、体征及功能好转;无效:入院前和出院时的症状、体征、功能无变化^{[3]427}。

2 结果(表1)

治疗结果 1 260名疗养员在治疗过程中,治疗组总有效率90.31%,无不良反应发生。对照组总有效率71.45%,有89人出现胃肠道反应,有1人停止治疗。两组进行疗效比较,治疗组的总有效率明显高于对照组,且无不良反应发生。

表1 两组疗养员疗效比较

组别	例数	治愈	显效	好转	无效	总有效率(%)	不良反应(%)
治疗组	640	328	152	98	62	90.31	0
对照组	620	257	121	65	177	71.45	14.35

3 讨论

膝关节骨性关节炎是引起中老年人膝关节疼痛的主要原因之一,一般认为与局部软骨变性和应力异常有关,其发病机制尚未完全明确,年龄、性别、遗传、肥胖、累积性应力、创伤等因素都可能引发,因此要尽量避免身体肥胖,防止加重膝关节的负担,一旦身体超重,就要积极控制体质量;注意走路和劳动的姿势,不要扭着身体走路和干活^[5]。我科根据祖国医学中医理论采用活血通络、祛风止痛中药,将中药打粉加工,严格称重分装入药袋,经地下温泉水浸泡后,其有效治疗成分充分溶解于温泉水中,机体通过浸泡、洗浴,药液作用于肌肤患处,行于经络,内达脏腑,由表及里产生效应,达到治疗疾病的目的。另外药浴通过温度和药物的共同作用促进血液循环和局部细胞的代谢,加强肌肉、肌腱和软骨损伤的修复,抑制滑膜炎症,使病变组织恢复^[6]。经我们临床疗效观察,治疗组的总有效率明显高于对照组,且治疗过程中治疗组运用得当无不良反应发生,说明对于膝关节骨性关节炎的治疗,

中药药浴是一种疗效肯定、安全可靠的方法。

参考文献:

- [1] 贾本让.膝关节骨性关节炎的诊治[J].人人健康,2012(8):51.
- [2] 吴孟超,吴在德.黄家驷外科学:下册[M].7版.北京:人民卫生出版社,2009:3025-3028.
- [3] 曹国英.疗养技术常规[M].北京:人民军医出版社,1999.
- [4] 熊淑云,熊静.中药熏洗配合盐酸氨基葡萄糖胶囊治疗膝骨性关节炎疗效观察[J].现代医药卫生,2010,26(6):907-908.
- [5] 包芸,包毅敏,咏梅.痹痛液药浴治疗膝骨性关节炎临床疗效观察[J].内蒙古中医药,2008(2):7-8.
- [6] 孔筠,张宁,肖延龄,等.中医药治疗法的现代理论与应用研究[J].中国医药,2009,4(5):398-400.

(收稿日期:2012-11-12)

文章编号:1005-619X(2013)02-0141-02

床旁上肢康复机器人用于脑梗死患者康复训练疗效观察

郭春花 闫玮娟 王丽

(济南军区青岛第二疗养院康复科,266071)

【关键词】 脑梗死;偏瘫;上肢康复机器人;康复训练;日常生活活动;上肢运动功能

脑梗死患者的神经系统症状及体征是由于局部脑组织供血障碍,脑组织缺血缺氧发生坏死而导致的。发病后,多数患者会遗留上肢功能活动障碍,会严重影响患者的独立生活能力及日常生活质量,并且出现焦虑、抑郁心态,影响日后的康复训练。2012-05—11我科采用床旁上肢智能康复机器人对28例脑梗死偏瘫患者在常规康复训练的基础上进行上肢训练,取得良好效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 28例脑梗死偏瘫患者,男18例,女10例;年龄36~72岁;左半球病变12例,右半球病变16例。全部

患者均符合1995年全国第四届脑血管病学术会议通过的诊断标准^[1],经头颅CT或MRI检查确诊。偏瘫侧上肢Brunstrom分期≥III期;肌张力(采用改良Ashworth量表评级)≤2级。

1.2 方法

1.2.1 训练方法 ①常规训练:给予康复科常规护理,保持患者在床上和轮椅上的良肢位,给予针对性的健康教育,指导患者向健侧翻身,指导患者用健手触摸患侧各部位^[2],并带动患侧肢体活动。每日给予运动疗法和作业疗法各30 min,内容包括关节活动度训练、肌力训练、诱发上

肢分离运动训练、ADL训练等。训练由治疗师“一对一”进行,根据患者的运动功能状况,分别采取独立、部分辅助、完全辅助等训练方式,6次/周,共训练4周。②床旁上肢智能康复机器人训练:采用KLW-SKF1智能康复机器人,训练调速范围0.2~0.5 m/s,一般0.4 m/s,训练时首先协助患者取舒适的体位,将机器人在患者床旁固定(防止训练过程中意外滑动),将患者的健侧手、手臂及患侧手、手臂同时与机器人相连,确保手臂安全牢固,根据患肢肌力选择适合的训练模式(机器人可分为六种模式,即神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式),1次/d,30 min/次,以肌肉稍感疲劳为度,6次/周,共训练8周,在训练中,如患者心率超过年龄标准化最高心率的75%或有头晕不适等症状时,应停止训练。

1.2.2 评价方法 由专人于训练前及训练8周后进行康复效果评定。采用简式Fugl-Meyer运动量表(FMA)进行偏瘫患者的上肢运动功能评定^[3];采用改良Barthel指数(MBL)评定患者日常生活能力^[4]。

1.2.3 统计学方法 采用SPSS 13.0进行系统分析,等级计数资料采用秩和检验,计量资料采用 t 检验, $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

患者上肢运动功能及日常生活能力较治疗前有明显的好转(表1)。

表1 患者康复训练前后FMA评分及MBL评分比较($\bar{x}\pm s$)

时间	例数	FMA	MBL
训练前	28	19.68 $\pm$ 10.05	7.55 $\pm$ 2.87
训练后	28	33.82 $\pm$ 10.69	38.82 $\pm$ 10.32
P		<0.05	<0.05

3 讨论

目前国内对脑梗死后肢体功能障碍的治疗主要依赖于治疗师“一对一”的徒手训练,难以实现高强度、有针对性和重复性的康复训练要求。床旁康复机器人从某种程度上解决了这一问题(尤其对长期卧床的患者),同时弥补了训练方法不科学及专业康复人员疏忽而造成的对病人损伤等问题。脑梗死偏瘫患者在恢复过程中往往会伴随有肌肉痉挛,影响患者的训练。患者在一定时间内进行高密度的重复运动,可以降低痉挛程度^[5],智能的康复训练系统可以为患者提供运动训练轨迹,带动患肢运动,恢

复肩肘关节的运动能力;可以为损伤上肢提供重力补偿,让患者更方便的运动并改善其残余的神经肌肉支配能力;通过游戏模式让患者在虚拟环境中进行功能性和趣味性的视频游戏训练,对患者产生实时的、针对性的运动信息反馈,使患者在上肢训练的过程中感受到训练的乐趣,激励患者按照医师的指导做更多的努力训练,同时缓解了患者的抑郁情绪,增强了康复信心,为早日回归社会做好准备。

本研究所用上肢机器人尚有不足之处,如无法进行腕关节的屈伸训练,在机器人辅助康复运动训练过程中很可能出现代偿运动使上肢的肩关节训练效果不确定,进而影响患者上肢运动功能的恢复,可以在训练中引入肩关节外展矫形器、肘夹板等辅助器具^[6],强制患者增加肩关节外展及防止出现过度共同运动代偿,使患者可以用正常人相似的运动规律进行康复运动训练,从而最终恢复或建立正确的运动模式。

本研究结果显示,患者在经常规康复训练基础上使用机器人训练,可明显促进脑梗死偏瘫患者上肢运动功能的恢复及日常生活活动能力的提高。

参考文献:

- [1] 中华神经科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379.
- [2] 杨薇,辛宁,徐贵侠,等.脑卒中后伴单侧空间忽略患者的康复护理[J].护理学杂志:综合版,2011,26(5):78-79.
- [3] 毕胜,纪树荣,顾越,等.Fugl-Meyer上肢运动功能评分与上肢运动功能状态评分的响应性研究[J].中国康复医学杂志,2006,21(2):118-120.
- [4] 闵瑜,吴媛媛,燕铁斌.改良Barthel指数(简体中文版)量表评定脑卒中患者日常生活活动能力的效度和信度研究[J].中华物理医学与康复杂志,2008(3):185-188.
- [5] Nuyens GE, De Weertdt WJ, Spaepen AJ Jr, et al. Reduction of spastic hypertonia during repeated passive knee movements in stroke patients[J]. Arch phys Med Rehabil, 2002, 83(7): 930-935.
- [6] 姚重阳,王子羲,季林红.机器人辅助上肢康复运动训练的代偿运动研究[J].中国康复医学杂志,2010,25(11):1085-1089.

(收稿日期:2012-12-03)

文章编号:1005-619X(2013)02-0142-02

诺和锐30治疗2型糖尿病41例临床观察

焦国亮 支世保 谢志浩
(沈阳军区兴城疗养院,125105)

【摘要】目的 观察诺和锐30治疗2型糖尿病的临床疗效。方法 41例2型糖尿病患者给予诺和锐30每日2次餐前即刻皮下注射,治疗12周,观察患者空腹血糖(FBG)、餐后2 h血糖(2 hPBG)、糖化血红蛋白(HbA_{1c})变化。结果 诺和锐30治疗后患者FBG、2 hPBG、HbA_{1c}明显低于治疗前($P<0.01$),且低血糖发生率较少。结论 诺和锐30控制2型糖尿病患者的FBG及2 hPBG效果满意。

【关键词】诺和锐30;2型糖尿病;空腹血糖;餐后2 h血糖;低血糖

目前糖尿病已经成为威胁人类生命、健康的重大疾病,其多器官损害是导致人类致残、致死的重要原因之一。而胰岛素抵抗和胰岛素分泌功能受损是2型糖尿病的主要病理表现,胰岛素 β 细胞功能缺陷是导致2型糖尿病患者血糖升高的关键因素^[1]。诺和锐30是一种胰岛素类似

物,能够双向释放混合胰岛素,并且起效快,可较好模拟胰岛素的生理分泌^[2]。本文使用诺和锐30治疗2型糖尿病患者41例临床疗效满意,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2011-07—2012-07来我院的2型糖